

○ 呼吸不全を呈するフレイルチェストの治療は陽圧換気による内固定術である。気管挿管下での人工呼吸管理だけでなく NPPV を用いることもでき、日本における NPPV ガイドラインでも推奨されている。但し、意識障害や顔面外傷による装着困難、排痰困難例などでは気管挿管もしくは気管切開による人工呼吸管理を選択すべきである。

× 成人患者において、外固定術は非手術例と比較して死亡率の低下や人工呼吸期間の短縮などが示されており、2017 年の EAST (The Eastern Association for the Surgery of Trauma guideline) ガイドラインでは弱い推奨となっている。従って、変形の大きい症例には外固定術も適応となる。

○ フレイルチェストは一般的に強い疼痛を伴い、疼痛による換気量の低下から呼吸不全が増悪するため除痛は必須となる。麻薬などの鎮痛薬の全身投与の他、重症例では持続硬膜外麻酔が推奨されている。

× 大量血胸の開胸止血術の適応として、①胸腔ドレナージ施行時 1000 mL 以上の血液を吸引、②胸腔ドレナージ開始 1 時間で 1500 mL 以上の血液を吸引、③ 2~4 時間で 200 mL/時以上の出血の持続、④持続する輸血が必要、の 4 項目がエキスパートオピニオンとして提唱されている。問題 11 では、バイタルサインが不安定で出血が持続している徴候があれば開胸術の適応となるが、単純に出血量のみでは開胸術の適応とはならない。

○ EAST のガイドラインでは、穿通性外傷と比較して鈍的外傷では出血量に基づいて止血を要することが少なかったことを根拠として問題文のような推奨となっている。

× 受傷直後には酸素化の低下があっても明らかな異常陰影を示さないことがあり、受傷数時間以内に明らかになることが多い。

× 80% 以上は気管分岐部から 2.5 cm 以内の損傷であるとされる。胸腔ドレナージを行っても虚脱の改善しない気胸や持続的な空気漏出がみられる場合に気管・気管支損傷を疑う。

○ CT の 3D 再構成などを用いて診断される例もあるが、気管支鏡検査が最も確定的な診断法である。